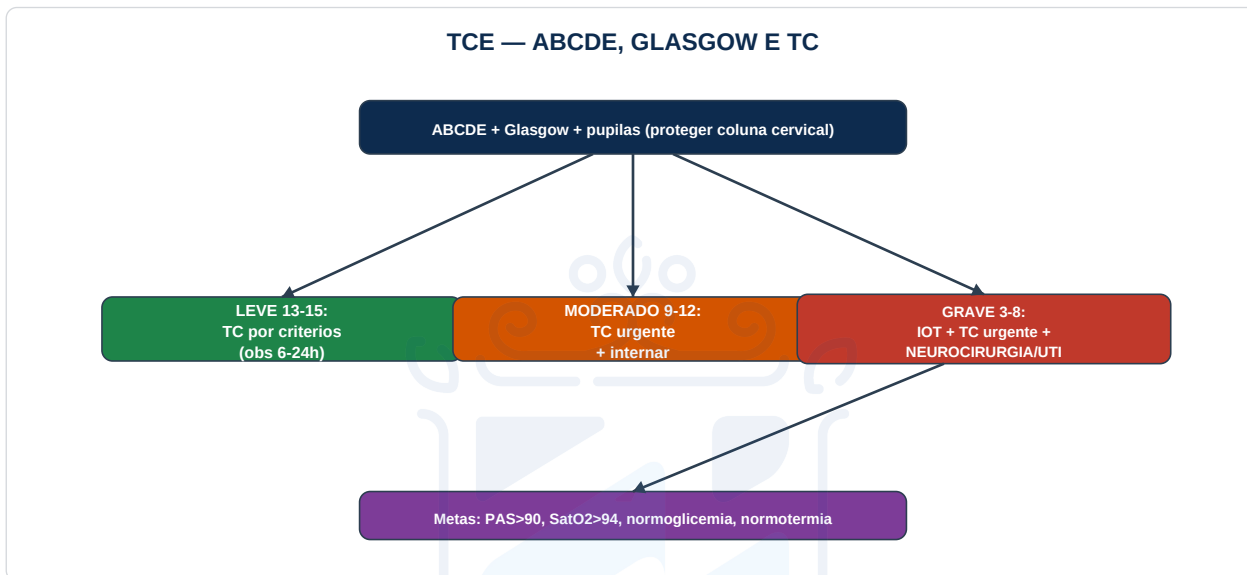


TCE NO ADULTO — GLASGOW, TC E METAS

FLUXOGRAMA — GRAVIDADE PELO GLASGOW



CLASSIFICAÇÃO E ABORDAGEM (ATLS)

GLASGOW DEFINE A GRAVIDADE

- TCE LEVE: Glasgow 13-15 | MODERADO: 9-12 | GRAVE: 3-8
- ABCDE com proteção cervical: colar rígido em TODO TCE até excluir lesão
- IOT se: Glasgow ≤ 8 , apneia, hipoxemia refratária, perda de reflexos de proteção
- HIPOTENSÃO no TCE = sangramento em OUTRO local (pesquisar tórax/abdome/pelve/ossos)
- Reavaliar Glasgow a cada 15-30 min; documentar SEMPRE o Glasgow inicial

EXAME FÍSICO — SINAIS DE FRATURA DE BASE / HERNIAÇÃO

RED FLAGS NEUROLÓGICOS

- Fratura de base de crânio: sinal do guaxinim (periorbitário bilateral), sinal de Battle (retroauricular), hemotímpano, otorreia/rinorreia líquorica
- Hipertensão intracraniana: tríade de Cushing (HAS + bradicardia + respiração irregular — TARDIO), cefaleia progressiva, vômitos em jato, rebaixamento
- Herniação UNCAL: anisocoria (pupila dilatada IPSILATERAL) + hemiparesia contralateral
- Herniação central: pupilas médio-fixas, decorticação/descerebração
- Deterioração aguda = queda ≥ 2 pontos no Glasgow -> repetir TC e acionar neurocirurgia

INDICAÇÕES DE TC DE CRÂNIO (TCE LEVE)

Critérios clínicos	Critérios de risco
Perda de consciência > 5 min; amnésia > 30 min	Idade ≥ 65 anos
Confusão persistente; ≥ 2 vômitos	Uso de ANTICOAGULANTE/antiagregante; coagulopatia
Cefaleia intensa progressiva; crise convulsiva	Mecanismo de alto impacto (queda > 1 m, alta velocidade)
Déficit focal; sinais de fratura de base	Atropelamento, ejeção de veículo

TRATAMENTO — MEDIDAS GERAIS E METAS

Rx SUPORTE + NEUROPROTEÇÃO

Via aérea pérvia + proteção cervical; O2 para SatO2 > 94%; 2 acessos; monitorização contínua
Cabeceira a 30 graus (se PA estável); normotermia (antitérmico se Tax > 37,5)
METAS: PAS > 90 mmHg (evitar hipotensão!), SatO2 > 94%, glicemia 80-180, PaCO2 35-40 (se IOT)
Reposição: SF 0,9% ou Ringer (EVITAR soluções hipotônicas/glicosadas)
Analgesia: Dipirona 1g EV 6/6h; Tramadol se dor moderada (evitar sedação que mascare o exame)
HIC/herniação: medidas (cabeceira, sedação/analgesia, salina hipertônica/manitol) + neurocirurgia urgente

PROFILAXIA DE CONVULSÃO E ANTICOAGULAÇÃO

ATENÇÃO

- Profilaxia de convulsão (Fenitoína 15-20 mg/kg EV ataque) se: hematoma intracraniano, fratura com afundamento, LAD, Glasgow < 10
- Uso de anticoagulante/antiagregante = INTERNAR (mesmo com TC normal) e considerar reversão
- Náusea/vômito: Ondansetrona 4-8 mg EV 8/8h
- TCE moderado/grave: SEMPRE TC urgente; grave -> contato imediato com neurocirurgia
- Repetir TC se: piora do Glasgow, novo déficit, cefaleia progressiva, vômitos, convulsão

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: Glasgow <= 12, qualquer lesão na TC, fratura de crânio, deterioração, déficit focal, convulsão, anticoagulante, sinais de fratura de base, vômitos/cefaleia persistentes
- ☐ UTI + neurocirurgia: Glasgow <= 8, lesão neurocirúrgica (epidural/subdural/contusão com efeito de massa), HIC/herniação, instabilidade, politrauma
- ☐ ALTA (TODOS): Glasgow 15, exame neuro normal, TC normal, obs >= 6h sem piora, sem anticoagulante, acompanhante responsável
- ☐ Alta: observação domiciliar 24-48h, repouso 48h, evitar álcool/dirigir 24h
- ☐ Retorno IMEDIATO: sonolência, confusão, >= 2 vômitos, cefaleia intensa, déficit, convulsão, saída de sangue/líquido por nariz/ouvido

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- TCE ____ (leve/moderado/grave). Mecanismo: _____. Glasgow na cena ____ / atual ____ (O_ V_ M_). Pupilas: _____.
- Sinais de fratura de base / afundamento / déficit focal: _____. PA ____, SatO2 _____.
- TC de crânio (se feito): ____ (epidural/subdural/contusão/HSA, desvio de linha média).
- Medidas: estabilização/IOT/reposição. Antecedentes: anticoagulante/etilismo. Solicito neurocirurgia urgente / UTI / TC.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com TCE, Glasgow 7. Além de TC urgente e neurocirurgia, qual a conduta imediata da via aérea?

- A) Cateter nasal de O₂ e observação
- B) Intubação orotraqueal (Glasgow $\leq$ 8) com proteção cervical
- C) Apenas máscara não reinalante
- D) Aguardar a TC para decidir
- E) Ventilação não invasiva

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com TCE e hipotensão arterial. Qual a interpretação correta?

- A) A hipotensão é explicada apenas pelo TCE
- B) A hipotensão indica sangramento em outro local — pesquisar tórax, abdome, pelve e ossos longos
- C) É esperada e não requer investigação
- D) Indica morte encefálica
- E) Deve ser tratada apenas com vasopressor

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado sugere fratura de base de crânio?

- A) Cefaleia leve
- B) Sinal do guaxinim, sinal de Battle, hemotímpano ou otorreia/rinorreia líquórica
- C) Febre isolada
- D) Hipertensão controlada
- E) Náusea leve

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual conjunto de metas fisiológicas reduz a lesão cerebral secundária no TCE grave?

- A) PAS < 90, SatO₂ < 90, hipotermia
- B) PAS > 90 mmHg, SatO₂ > 94%, normoglicemia, PaCO₂ 35-40 mmHg e normotermia
- C) Hiperventilação de rotina
- D) Glicemia > 250 mg/dL
- E) Hipotensão permissiva agressiva

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente com TCE leve (Glasgow 15) em uso de varfarina, TC inicial normal. Conduta?

- A) Alta imediata sem observação
- B) Internar para observação (mesmo com TC normal), pelo risco de sangramento tardio sob anticoagulação
- C) Repetir TC apenas em 30 dias
- D) Suspender a varfarina e dar alta
- E) Apenas analgésico e alta

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Glasgow ≤ 8 indica via aérea definitiva: IOT com proteção da coluna cervical, para proteger a via aérea e controlar a ventilação (PaCO_2 -alvo), evitando hipóxia/hipercapnia que agravam a lesão secundária.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O TCE isolado raramente causa hipotensão (exceto fase terminal). Hipotensão no trauma é hemorrágica até prova em contrário — pesquisar tórax, abdome, pelve e ossos longos. Manter PAS > 90 (hipotensão piora o TCE).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sinal do guaxinim (equimose periorbitária bilateral), sinal de Battle (retroauricular), hemotímpano e fístula liquórica (otorreia/rinorreia) sugerem fratura de base de crânio.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

As metas no TCE grave são PAS > 90 , $\text{SatO}_2 > 94\%$, normoglicemia (80-180), PaCO_2 35-40 e normotermia — evitam a lesão cerebral secundária. Hiperventilação de rotina e hipotensão são deletérias.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

TCE leve em uso de anticoagulante exige internação para observação mesmo com TC inicial normal, pelo risco de hemorragia intracraniana tardia; considera-se ainda reversão da anticoagulação conforme o caso.

SM24
Suporte ao Plantão Médico